



دليل زيادة الوزن والبدانة للملاكات الصحية

دائرة الصحة العامة
قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

٢٠٢٢

الاشراف

د. رياض عبد الامير الحلفي

مدير عام دائرة الصحة العامة

الاعداد:

- **د. فارس عبد الكريم خزعل/ زميل كلية الاطباء الملكية/ البورد العربي الطب الباطني/ عميد كلية مدينة العلم**
- **د. منى عطا الله خليفة علي/FICMS/ طب مجتمع/ مديرة قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية/ دائرة الصحة العامة.**
- **د.ندى عبد الوهاب موسى/ PHD/ طب مجتمع/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية/ دائرة الصحة العامة.**
- **د. بشرى ابراهيم عبد اللطيف/ MSc/طب مجتمع/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية/ دائرة الصحة العامة.**
- **د. بتول علي حسن/ FICMS/ طب اسرة/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية/ دائرة الصحة العامة.**
- **د.فاتن كاظم حمادي/MSc / طب مجتمع/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية/ دائرة الصحة العامة**
- **د.هديل محمد جاسم/ بورد عربي طب مجتمع/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية/ دائرة الصحة العامة**
- **د. محمد عبد الرضا عباس/ بورد عربي طب مجتمع/ مستشفى الشهيد الصدر/ دائرة صحة بغداد/ الرصافة.**

المقدمة

السمنة سبب للعديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، عالميا مستويات الاصابة بالسمنة وصلت إلى مستويات وبائية في كل البلدان المتقدمة والنامية حيث تصيب ليس فقط البالغين بل أيضا اليافعين والأطفال.

على مدى السنوات الماضية، أصبحت السمنة مشكلة التغذية الأكثر انتشارا، بل انها عامل خطر لكثير من الامراض المزمنة. المسوحات الوطنية تبين زيادة في معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة بين البالغين بين عامي ٢٠٠٦و٢٠١٥ ليصل (٥٨,٧%) بين الذكور و(٧٣,٢) بين الاناث البالغين ١٨ سنة فأكثر.

معالجة الوزن الزائد تشتمل دائما على تغيير بعض أشكال نمط الحياة لخفض كمية الطاقة و/ أو زيادة صرف الطاقة، ولكن هناك مجموعة من العلاجات تبدأ من تعديل السلوك وتصل إلى إجراء العملية الجراحية التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى الهدف المحدد.

الهدف من هذا الدليل

تم اعداد هذا الدليل للملاكات الصحية للتعريف بزيادة الوزن والسمنة والتدابير العلاجية للتعامل مع الحالات لبناء القدرات لتكامل العمل مع الاطباء في تقديم المشورة كجزء من حزمة خدمات الرعاية الصحية الاولية للامراض غير الانتقالية.

التعريف:

تعرف السمنة بأنها التجمع المتراكم أو غيرالطبيعي للدهون في الجسم والذي يشكل خطرا على الصحة، تحصل السمنة عندما تكون الطاقة التي تدخل الجسم عن طريق الطعام والشراب أكثر من الطاقة التي يحتاجها في عمليات الايض الغذائي وعلى مدة من الزمن مما يؤدي الى تراكم الدهون في الجسم.



الجزء الاول

معالجة زيادة الوزن والسمنة لدى البالغين

ست خطوات لمعالجة زيادة الوزن والسمنة لدى البالغين:

١) قياس مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر
٢) تقييم الأسباب الكامنة وعوامل الخطورة لزيادة الوزن/ السمنة
٣) تقييم الأمراض المصاحبة
٤) تحديد الأهداف ومستويات المعالجة
٥) تقديم المشورة للعلاج التغذوي والنشاط البدني
٦) الأدوية أو اللجوء لجراحة السمنة

الخطوة (١) قياس مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر

بهذه المرحلة تتم المناقشة مع المريض حول وزنه وينبغي أن يتم ذلك عن طريق قياس وزن الجسم والطول ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وتقييم مدى استعداد ورغبة المريض في فقدان الوزن كعلاج اساسي لأضطرابات التمثيل الغذائي المختلفة.

مؤشر كتلة الجسم BMI (Body Mass Index): يقاس الوزن (كغم)/ مربع الطول (م^2) يستخدم هذا المؤشرفي معظم الأحيان، إلا أنه ليس دائما مؤشرا دقيقا للدهون في الجسم أوتوزيع الدهون.

قياس محيط الخصر Abdominal Circumference: يقاس عند نقطة الوسط بين أدنى ضلع وقمة عظم الحوض (iliac crest) من على السرة. وهو قياس للدهون الحشوية بشكل غير مباشر ويعتبر مؤشراً افضل للمخاطر الصحية في بعض الظروف. لغرض تقييم الخطورة والتغيرالنسبي يتم جمع مؤشركتلة الجسم ومحيط الخصر(جدول١).

جدول رقم (١): مؤشر كتلة الجسم وقياس محيط الخصر لتقييم زيادة الوزن والسمنة

	مؤشر كتلة الجسم (Kg/M^2)	خطر المرض نسبة إلى القياسات العادية	
		محيط الخصر الرجال أقل من ١٠٢ سم المرأة أقل من ٨٨سم	محيط الخصر الرجال١٠٢ سم فأكثر المرأة ٨٨سم فأكثر
طبيعي	١٨,٥-٢٤,٩ كغم/ م٢	ضمن الطبيعي	زيادة
زيادة الوزن	٢٥ - ٢٩,٩ كغم/ م٢	زيادة	زيادة
السمنة	٣٠ –٣٤,٩ كغم/ م^2	عالية-عالية جدا	عالية جداً
السمنة المفرطة	٤٠ فأكثر كغم/ م^2	عالية للغاية	عالية للغاية

الخطوة (٢) تقييم الأسباب الكامنة وعوامل الخطورة لزيادة الوزن/السمنة:

يتم تحديد الأسباب من قبل الطبيب وكما يلي :

- العادات الغذائية غير الصحية.
- العوامل البيئية، كبيئة المنزل والعمل والمجتمع
- التأثيرات الوراثية.
- التعرض إلى الإجهاد
- الأدوية
- الحالات المرضية التي تسبب زيادة الوزن (مثل قصور الغدة الدرقية)

الخطوة (٣) تقييم المراضة المصاحبة:

هناك العديد من الأمراض المصاحبة لزيادة الوزن والبدانة ويمكن السيطرة عليها من خلال فقدان الوزن والتي تنتج إما عن مضاعفات التمثيل الغذائي أو زيادة وزن الجسم نفسه. فقدان الوزن له تأثير مفيد في التقليل من الامراض التالية:

- ضغط الدم عند المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم .
- ارتفاع السكرفي الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني
- المستويات العالية للدهون والدهون الثلاثية عند المرضى الذين لديهم اضطراب في مستوى الدهون عن المستوى الطبيعي.
- بالإضافة إلى ذلك تحسين كل من تقدير الذات ونوعية الحياة.

الخطوة (٤) تحديد الأهداف ومستويات المعالجة:

يتم تحديد طريقة العلاج من قبل الطبيب وحسب الجدول المرفق :

دليل لمناقشة تحديد المستوى الأولي من التداخلات			
تصنيف مؤشر كتلة الجسم BMI	محيط الخصر		وجود امراض مصاحبة
	الرجال أقل من١٠٢ سم النساء اقل من ٨٨سم	للرجال ١٠٢سم فأكثر النساء ٨٨سم فأكثر	
زيادة الوزن (٢٥-٢٩,٩ كغم/ م^{٢})			
السمنة ١ (٣٠ –٣٤,٩ كغم/ م^{٢})			
السمنة٢ (٣٥–٣٩,٩ كغم/ م^{٢})			
السمنة٣ (٤٠ فأكثركغم/ م^{٢})			

نصائح عامة حول انماط الحياة الصحية.
العلاج التغذوي والنشاط البدني.
العلاج التغذوي والنشاط البدني، احالة للنظرفي وصف الأدوية.
العلاج التغذوي والنشاط البدني، احالة للنظر في وصف الأدوية، النظر في الجراحة.

- **الهدف الأساسي للسيطرة على الوزن هو تحسن الوضع الصحي**

لتقليل خطورة الأمراض المصاحبة ينبغي التخلص من (٥-١٠%) من الوزن الزائد والوصول إلى محيط الخصر المثالي وهي للرجال اقل من ١٠٢ سم، والوصول إلى محيط الخصر المثالي للنساء اقل من ٨٨ سم.

الخطوة (٥) تقديم المشورة للعلاج التغذوي وتعزيز النشاط البدني

الشرط الرئيسي لإتباع النظام الغذائي اللازم لفقدان الوزن هو خفض إجمالي كمية الطاقة الداخلة للجسم التي يمكن أن تستمر بمرور الوقت مع توفير جميع العناصر الغذائية الأساسية بكميات كافية. يجب ان يصاحب النظام الغذائي ممارسة النشاط البدني الملائم للعمر و للحالة الصحية وحسب الارشادات الطبية.

المشورة للعلاج الغذائي:

- إتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ١٢٠٠ -١٦٠٠ كيلو سعره حرارية من الطاقة يوميا.
- النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية عادة يشجع على تقليل كمية الدهون المتناولة باعتبارها وسيلة عملية لتقليل السعرات الحرارية ومكوناتها الغذائية التي من شأنها تقليل عوامل الخطورة الاخرى.
- اتباع النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يقلل من وزن الجسم الكلي بمعدل ٨% ويساعدعلى تقليل محتوى الدهون في منطقة البطن خلال حوالى ستة أشهر.
- عندما يحدث فقدان الوزن، يتكون من فقدان حوالى ٧٥% من الدهون و٢٥% من أنسجة العضلات والأنسجة الأخرى.
- ان تقليل ٥٠٠ - ١٠٠٠ كيلوسعره حرارية في اليوم ينتج عنه نقص في الوزن ٧٠-١٤٠ غم في اليوم. وتقليل ٣٠٠ – ٥٠٠ كيلو سعره حرارية/ في اليوم ينتج عنه فقدان ٤٠ – ٧٠ غرام من الوزن يوميا.
- قد يختار المريض نظام غذائي من ١٢٠٠ سعره حرارية للنساء و ١٨٠٠سعره حرارية للرجال. (الملحق٢ أ،٢ب) .

الارشادات الاساسية لفقدان الوزن:

- **تجنب:**
  - الطعام المقلي
  - الوجبات السريعة
  - الأطعمة التي تحتوي على السكر أو الدهون المشبعة
  - المشروبات والحلويات غنية بالسكر المضاف.
  - تناول الكحول





كن على علم بان :

- العودة إلى وزن الجسم الطبيعي قد يكون صعباً.
- فقدان ١٠% من الوزن يمكن ان يكون هدفا واقعيا كبداية.
- بالنسبة لبعض الناس، الحفاظ على الوزن يكون هدفا أكثر واقعية .

- **تغيير عادات الأكل هوالتحدي**

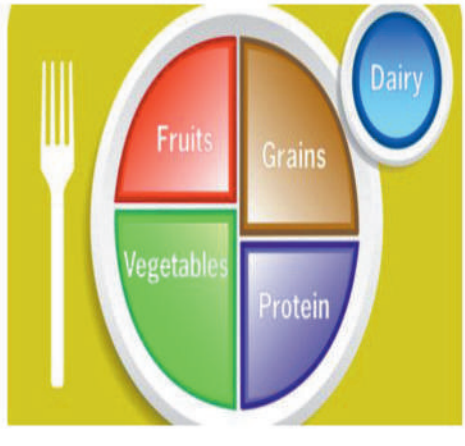
- ابدأ مع اثنين أوثلاثة تغييرات محددة على سبيل المثال:
- الفاكهة بدلا من الحلوى
- زيت الزيتون بدلا من الزبد
- ينبغي أن يتكون الصحن الذي تتناوله يوميا على ما يأتي:
- ربع من الفاكهة
- ربع من الخضار
- ربع من الحبوب
- ربع من البروتينات كاللحوم والدواجن والاسماك
- قدح من الحليب أو اللبن (الزبادي)

المشورة لتعزيز النشاط البدني:

النشاط البدني: هو أي قوة او مجهود تسلطه العضلات الارادية والذي يؤدي الى صرف طاقة فوق مستوى السكون او الراحة

اجمالي الطاقة المصروفة يومياً:

- الطاقة المصروفة في حالة السكون (الوظائف الحيوية للأعضاء)٦٠-٧٥%
- الطاقة المصروفة للنشاط البدني (الحركة فوق السكون)١٥-٣٠%
- التأثير الحراري للغذاء (الطاقة المطلوبة لهضم الغذاء) ١٠%





هناك نوعان من النشاط البدني :

١- **النشاط البدني المخطط له :** وهو نوع من النشاط البدني الذي يكون منظم قابل للاعادة ويهدف الى تحسين الصحة واللياقة كالتمارين الرياضية او لعبة كرة القدم او السلة.

٢- **النشاط البدني غير المخطط له** : وهويشمل الاعمال اليومية غير المرتبطة ببرنامج منظم والتي هي جزء من حياتنا ويشمل اي نوع من الفعاليات اليومية مثل اعمال المنزل، التسوق، ركوب الدراجة، العمل في الحديقة، التنقل بالمشي او ركوب الدراجة.

مجالات النشاط البدني هي :

- **خلال العمل:** الحركة، حمل الاغراض، عمل مكتبي.
- **في المنزل:** التنظيف، العمل في الحديقة، التسوق.
- **اثناء التنقل:** الى العمل، المدرسة، السوق، بواسطة المشي او ركوب دراجة هوائية سواءً صعودا او نزولا.
- **اوقات الفراغ:**التمارين الرياضية، مباريات رياضية، فعاليات ترفيهية

الطاقة المصروفة في اليوم الواحد = مجموع الطاقة المصروفة في كل المجالات: العمل +المنزل+التنقل+اوقات الفراغ.

يوصف النشاط البدني بناءاً على اربعة عناصر:

١. **طبيعة النشاط البدني** Mode: أما هوائية أو مقاومة لتقوية العضلات أوتقوية العظام أو تمارين المرونة
   - النشاطات الهوائية: ويقصد بها المشي وركوب الدراجة واللعب في الهواء الطلق.
   - تمارين مقاومة تقوية العضلات: ويقصد بها تمارين المقاومة بأستعمال الأشرطة المطاطية، شد الحبل، الجلوس والوقوف والجمناستك والجري.
   - تمارين تقوية العظام: ويقصد بها الجري ،القفز العريض، القفز بالحبل، الجمناستك، كرة السلة، كرة الطائرة والتنس
   - تمارين المرونة: مثل اليوغا وتمطية العضلات
٢. **الشدة** Intensity : مؤشر لصرف الطاقة، تكون طريقة القياس:
٣. القياس بشكل شخصي (غير موضوعي) subjective.
   - القياس بشكل موضوعي objective من خلال احتساب الايض المكافىء.
٤. **التكرار** Frequency: عدد المرات لكل جلسة (١٠ دقائق أو أكثر) يوميا أوأسبوعيا
٥. **المدة** Duration: بالدقائق أو الساعات لفترة محددة (في اليوم أوالأسبوع)

انواع النشاط البدني حسب الشدة :

١. نشاط بدني قليل الشدة يكون غير مصحوب بتسارع نبضات القلب والتنفس
٢. نشاط بدني متوسط الشدة يكون مصحوب بتسارع نبضات القلب والتنفس
٣. نشاط بدني شاق يكون مصحوب بتسارع نبضات القلب والتنفس مع صعوبة الكلام و/ أو التعرق

المكافئ الايضي (Metabolic equivalent)

يرمز له عادة بالرمز (**MET**)، وهو يعني مقدار الطاقة المصروفة من قبل الجسم منسوبة الى ما يصرف اثناء الراحة والمعروف ان الجسم يصرف طاقة مقدارها واحد مكافئ ايضي في الراحة، وهو مايساوي تقريبا ٣.٥ مليلتر من الاوكسجين لكل كيلوجرام من وزن الجسم في الدقيقة.

احتساب الايض المكافىء (وحدة قياس النشاط البدني) MET :Metabolic Equivalent

- قليل الشدة: اقل من ٣ MET لا تسبب زيادة في التنفس وإسراع نبضات القلب
- متوسط الشدة: ٣-٦ METتسبب زيادة طفيفة في التنفس وإسراع نبضات القلب
- شاق: اكثر من ٦ MET تسبب زيادة في التنفس و تسارع في نبضات القلب وصعوبة التحدث و/ أوالتعرق

أمثلة	MET	الشدة
مشي بطيء جدا (٢.٧كم/ ساعة/) أرض مستوية	٢.٣	قليل
مشي بطيء (٤ كغم/ ساعة)	٢.٩	قليل
مشي سريع	٥	متوسط
مشي سريع بقوة هرولة	٨	شاق
ركض	١١.٥	شاق

لتحقيق الفائدة الصحية من النشاط البدني بالنسبة للبالغين يجب أن يحققوا ٦٠٠ MET من النشاط البدني أسبوعيا، وكالأتي :

- نشاط متوسط الشدة (٤ MET) لمدة ٣٠ دقيقة في اليوم على الأقل ٥ أيام/ أسبوع على الأقل (١٥٠ دقيقة في الأسبوع).
- أو نشاط شاق (٨ MET) لمدة ١٥ دقيقة في اليوم على الأقل ٥أيام/ أسبوع (٧٥ دقيقة في الأسبوع).
- أو نشاط متوسط و نشاط شاق مجموعه ٦٠٠ MET في الأسبوع

ان فترة إجراء النشاط البدني اليومي يمكن تجميعها على دفعات على أن لا تقل كل دفعة عن ١٠ دقائق.

مثلا :

- شخص يمشي بسرعة متوسطة لمدة ٣٠ دقيقة
- ٤X٣٠ = ١٢٠MET.min
- شخص يركض لمدة ١٥ دقيقة
- ٨X١٥= ١٢٠MET.min

تصنيف شدة النشاط البدني تبعا لمقدار المكافئ الايضي

أن الانشطة البدنية التي تتطلب طاقة اقل من ٣ مكافئ أيضي تعد أنشطة بدنية منخفضة الشدة، وتلك التي تتطلب طاقة من ٣ الى أقل من ٦ مكافئ ايضي تعد معتدلة الشدة، اما الانشطة البدنية التي تتطلب طاقة تصل الى ٦ مكافئ ايضي فأكثر فتعد مرتفعة الشدة، علما بان المكافئ الايضي الاقصى المتوقع لشاب غير رياضي يبلغ حوالي ١٢-١٣ مكافئا ايضيا، الا أن هذا الرقم يتضائل مع التقدم في العمر بدءاً من نهاية العشرينات من العمر.

الطاقة المصروفة خلال النشاط البدني (Physical Activity Energy Expenditure)

هي كمية الطاقة معبرا عنها بالمكافئ الايضي أو بالكيلو سعر حراري، أو بالكيلو جول، والناجمة عن النشاط البدني، سواء كان ذلك النشاط نشاطا بدنيا حياتيا أم نشاطا رياضيا أو من أنشطة اللياقة البدنية، أو نشاطا بدنيا مرتبطا بالعمل. وعادة ماتكون الطاقة المصروفة من خلال النشاط البدني لدى الشخص النشيط بدنيا (أو الرياضي) أكبر من غير النشيط عندما يتم نسبتها الى الطاقة الكلية المصروفة من قبل ذلك الشخص، وعموما تبلغ الطاقة المصروفة من خلال النشاط البدني للشخص غير الرياضي حوالي ٢٠-٣٠% من مجمل الطاقة الكلية المصروفة في اليوم، أما بعض الرياضيين الذين يمارسون تدريبات بدنية شاقة يوميا ، فتصل مساهمة النشاط البدني لديهم الى مايقارب ٥٠% من مجمل الطاقة الكلية المصروفة في اليوم.

توصيات منظمة الصحة العالمية حول كمية النشاط البدني وحسب الفئات العمرية المختلفة:

مستوى النشاط البدني الذي ينبغي على الافراد الوصول اليه كي تتحقق الفائدة الصحية من النشاط البدني:

الأطفال واليافعين:

- ممارسة التمارين الهوائية المتوسطة الشدة وتقوية العضلات وتقوية العظام لمدة ٦٠ دقيقة / اليوم.
- من الممكن أن تكون ال ٦٠ دقيقة/ يوم متصلة أو متقطعة مثلاً ٢٠ دقيقة صباحاً، ٢٠ دقيقة بعد الظهر و ٢٠ دقيقة ليلا.
- أن ساعات الترفيه التي يقضيها الأطفال في اللعب مع اقرانهم أو الذهاب الى المدرسة مثلاً مشيا على الاقدام جميعها تحتسب من ضمن النشاط البدني المطلوب تحقيقه، حيث أن الفائدة تراكمية.

البالغين لمن تتراوح اعمارهم (١٨-٦٠) سنة وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية:

- ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة ٣٠ دقيقة/ اليوم خمسة ايام في الاسبوع أو ما يعادل ١٥٠ دقيقة/ اسبوع.
- فترة اجراء النشاط البدني اليومي يمكن تجميعها على دفعات على ان لا تقل كل دفعة عن ١٠دقائق.
- ينبغي لهم مزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة ١٥٠ دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع، أو النشاط البدني عالي الشدة لمدة ٧٥ دقيقة على مدار الأسبوع، أو مزيج من النشاط المعتدل والنشاط عالي الشدة بما يعادل ذلك.
- وللحصول على فوائد صحية إضافية، ينبغي للبالغين زيادة فترة مزاولتهم للنشاط البدني المعتدل إلى ٣٠٠ دقيقة أسبوعياً، أو ما يعادل ذلك.
- وينبغي مزاولة الأنشطة المقوية للعضلات التي تستهدف المجموعات العضلية الرئيسية، في يومين أو أكثر من أيام الأسبوع.

البالغين للذين اعمارهم اكبر من ٦٠ سنة وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية:

- ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة ٣٠ دقيقة/ اليوم خمسة ايام في الاسبوع أو ما يعادل ١٥٠دقيقة/ اسبوع.
- فترة اجراء النشاط البدني اليومي يمكن تجميعها على دفعات على ان لا تقل كل دفعة عن ١٠ دقائق.
- ينبغي لهم مزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة ١٥٠ دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع، أو النشاط البدني الحاد لمدة ٧٥ دقيقة على مدار الأسبوع، أو مزيج من النشاط المعتدل والنشاط الحاد بما يعادل ذلك.
- وللحصول على فوائد صحية إضافية، ينبغي لهم زيادة فترة مزاولتهم للنشاط البدني المعتدل إلى ٣٠٠ دقيقة أسبوعياً، أو ما يعادل ذلك.
- أما الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة على الحركة فينبغي لهم مزاولة النشاط البدني الذي يُحسّن التوازن ويقي من السقوط ٣ مرات أو أكثر أسبوعياً.
- وينبغي مزاولة الأنشطة المقوية للعضلات التي تشمل المجموعات العضلية الرئيسية في يومين أو أكثر من أيام الأسبوع.
- تختلف حدة مختلف أشكال النشاط البدني من شخص إلى شخص. وينبغي ممارسة جميع الأنشطة على دفعات يستمر كل منها ١٠ دقائق حتى تعود بالفائدة على صحة القلب والجهاز التنفسي.

التأثيرات الصحية للنشاط البدني

- تحسين اللياقة العضلية والقلبية
- تحسين صحة العظام والعضلات
- تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكري وانواع مختلفه من السرطانات بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون
- يحمي الشخص من الاكتئاب

النقاط المهمة في ممارسة النشاط البدني :

- ممارسة الرياضة وحدها غير كافية ويجب أن تكون مجتمعة مع نظام غذائي سليم.
- يجب القيام بتمارين الإحماء قبل ممارسة الرياضة والتهدئة بعدها.
- من المستحسن استخدام الأحذية الرياضية والجواريب السميكة لحماية الركبة أو القدم.
- ينبغي أن يبدأ التمرين بشدة خفيفة ولمدة قصيرة من الزمن، ويستمربزيادة تدريجيا إلى شدة أعلى ومدة أطول.
- يجب توجيه المرضى بتناول الفاكهة والخضار لمنع الزيادة في الجذور الحرة الناجمة عن ممارسة الرياضة، وتزويدهم بفيتامينات C و E إذا لزم الأمر.
- ينبغي إتباع تقنيات العلاج الجماعي والعلاج عن طريق تعديل السلوك.
- ينبغي تصميم تمارين للمرضى الذين يعانون من أمراض أخرى متزامنة بشكل فردي وتحت إشراف متخصصين

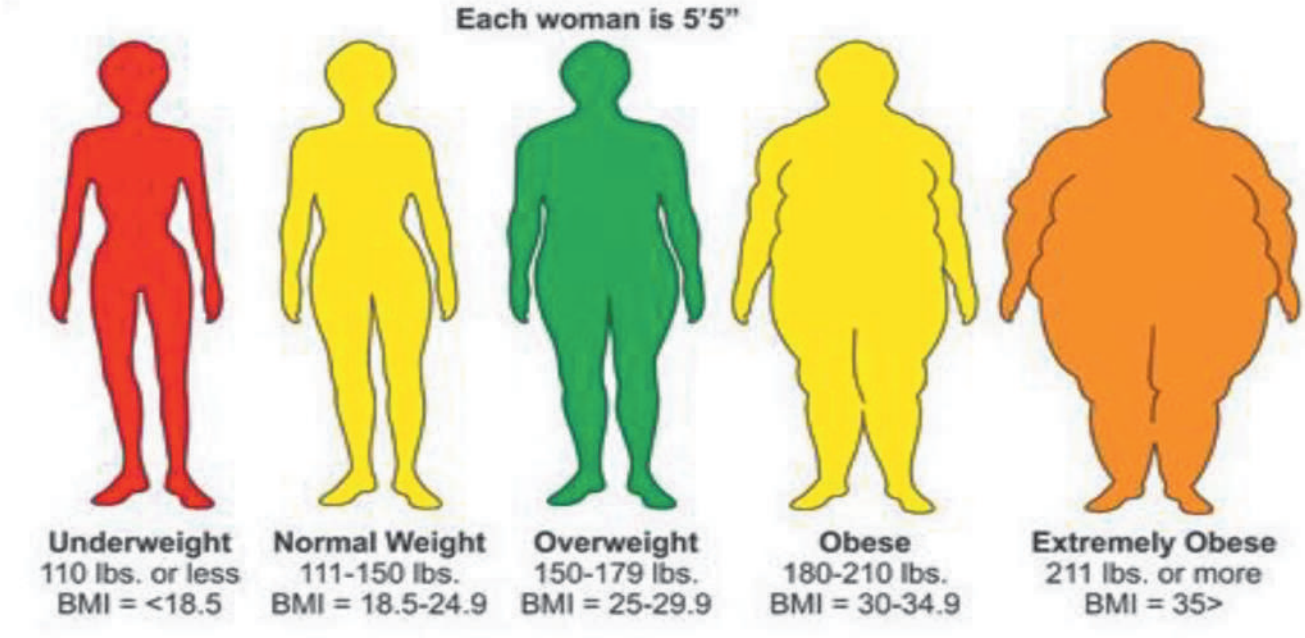
الخطوة (٦) الأدوية أواللجوء لجراحة السمنة:

تقرر من قبل الطبيب

الجزءالثاني

زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال واليافعين

تعتبرزيادة الوزن والسمنة مشكلة خطيرة عندالأطفال تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ، لوحظ من خلال مسح المغذيات الدقيقة والذي تم تنفيذه (٢٠١١-٢٠١٢) إن نسبة البدانة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (٦-١٢سنة) = ٧% أما بالنسبة لليافعين فتصل زيادة الوزن ٢٤.٣% لدى الذكور و٢٦.٦% لدى الإناث والبدانة ١،٧% لدى الذكور و٨,٩% لدى الإناث.



يتم اتباع خمس خطوات لمعالجة زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال واليافعين:



١) تقييم مدى زيادة الوزن/ السمنة في الاطفال أو اليافعين .
٢) تقييم الامراض المصاحبة لزيادة الوزن/ السمنة والتعامل مع كل حالة بصورة منفردة.
٣) تحديد مسببات وعوامل الخطورة لزيادة الوزن/ السمنة.
٤) مناقشة خطة العلاج وتحديد الأهداف الرئيسية ومستوى التدخل السريري المطلوب مع المريض والاسرة.
٥) المراجعة وتقديم المساعدة الدورية المنتظمة لمعالجة زيادة الوزن والمحافظة عليه .
٦) المشورة حول الاستراتيجية العلاجية مع المريض وعائلته



الخطوة (١) تقييم مدى زيادة الوزن/ السمنة في الأطفال أو اليافعين.

ينبغي أن يشمل الفحص البدني الأولي قياسات الطول والوزن وحسب مايلي:

- الطول/ الارتفاع : باستخدام شريط قياس (فيته) معتمد جداريه لقياس الطول، تكون القراءة إلى اقرب ملليمتر.
- الوزن : باستخدام لميزان قياسي وتكون القراءة لأقرب ٠.١ كيلوغرام.
- يتم احتساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) = $\frac{\text{وزن الجسم الحالي(كغم)}}{\text{مربع الطول بالمتر (م}^2\text{)}}$

- يتم استخدام منحنى النمو للذكور والاناث الخاص بمؤشركتلة الجسم بالنسبة للعمرلتحديد ما إذا كان الطفل أواليافع يعاني من زيادة الوزن أو من السمنة المفرطة.
مؤشركتلة الجسم فوق (SD ١ +) يعني زيادة الوزن وفوق (SD ٢ +) يعني السمنة.
لاتوجد تعريفات للسمنة وزيادة الوزن للأطفال أقل من ٢ سنة من العمر.(ملحق رقم ٥)

خطوة (٢) تقييم الامراض المصاحبة لزيادة الوزن/ السمنة، والتعامل مع كل حالة بصورة منفردة

يتم السؤال عن وجود هذه الحالات اعلاه واحالتها للطبيب.

- ارتفاع ضغط الدم : الأطفال الذين يعانون من السمنة معرضون لخطورة الاصابة بارتفاع ضغط الدم بحوالي ثلاثة أضعاف الأطفال الاخرين.
- أضطراب الدهون: غالبا ما يبدأ أضطراب دهون الدم في مرحلة الطفولة والمراهقة ويستمر حتى مرحلة البلوغ. يساهم أضطراب دهون الدم لدى الاطفال في الاصابة بتصلب الشرايين المبكر، والى الاصابة بخطورة عالية في تقييم خطورة الاصابة بأمراض القلب لدى الاطفال.
- السكري من النوع الثاني: أصبح أكثرشيوعا بين اليافعين
- مشاكل جراحة العظام: تراجع أوانزلاق رأس الكردوس (capital epiphysis) هوالأكثرخطورة.
- أمراض الجهازالتنفسي : وتشمل هذه الانسداد، توقف التنفس أثناء النوم.
- حالات الجهاز البولي والتناسلي: مثل اضطرابات الحيض. ابحث وأسأل عن أي اضطراب في البلوغ، والاحالة إلى أخصائي إذا تطلب الأمر.
- مشاكل نفسية: قد يعاني الأطفال من سن سبع سنوات من العزلة الاجتماعية والاكتئاب وسخرية الاخرين لاصابتهم بالسمنة.
- حالات مرضية أخرى: يجب السؤال عن أي اضطراب في البلوغ، والاحالة إلى أخصائي إذا تطلب الأمر.

الخطوة (٣) تحديد المسببات وعوامل الخطورة لزيادة الوزن/ البدانة:

ينبغي تقييم العوامل التي قد تؤثر على خطة العلاج من قبل الطبيب:

- الاستعداد الوراثي: هناك مؤشران يوحيان بوجود الاستعداد الوراثي وينبغي أن يحال المصاب إلى المستشفى للتقييم:
  ١. السمنة الشديدة اوالمرضية لدى الأقارب من الدرجة الأولى.
  ٢. السمنة في عمر مبكر جداً
- البيئة الأسرية، المدرسية والاجتماعية: تؤثر على زيادة الوزن وعدم القدرةعلى إنقاصه.
- الحالات المرضية:هناك علاقة بين السمنة وعدد من اضطرابات الغدد الصماء (مثل قصورالغدة الدرقية، داء كوشينغ ونقص هرمون النموأوالمقاومة له) وتتميز هذه الاضطرابات بالقصر في الطول (التقزم).
- المتلازمات الخلقية: من الأمثلة على ذلك برادر ويلي، باردیه -بيدل ومتلازمات كوهين Prader-Willi. Bardet-Beiedl & Cohen syndromes.
- الادوية على سبيل المثال المنشطات، أدوية الأمراض العقلية وغيرها من الأدوية.

لصعوبة قياس السلوكيات الخاصة بالنظام الغذائي والنشاط البدني بدقة لدى الأطفال واليافعين، الأسئلة التالية قد تعطي مؤشراعن نمط الحياة وكيفية حدوث اختلال توازن الطاقة:

- ساعات مشاهدة التلفزيون وغيرها من وسائل الترفيه على الشاشة الصغيرة.
- الوقت الذي يقضيه في ممارسة النشاط البدني المنظم.
- الفرص المتاحة للمشاركة في النشاط.
- نشاط أو خمول الوالدين.
- مستوى النشاط مقارنة مع أقرانهم.
- الجوع وطلبات المواد الغذائية.
- تناول الطعام أمام التلفزيون.
- نوع الوجبة.
- اختيارالوجبات الخفيفة.
- مقدارالطعام الذي يتم تناوله في وجبة الطعام، على سبيل المثال، مقارنة مع الوالدين.
- استخدام الغذاء كمكافأة أو ترفيه.
- امثلة على ممارسة النشاط البدني (وحدة احتساب الأيض المكافئ) (ملحق ٤)

ويتم التطبيق العملي للمشورة الصحية فيما يخص النشاط البدني والغذاء الصحي للذين لديهم زيادة في الوزن، اما المرضى اللذين يعانون من السمنة فيتم احالتهم الى عيادات التغذية في المستشفيات لاجراء الفحوصات اللازمة والتي تؤكد ان السمنة بسبب اتباع انماط الحياة غير الصحية أو هنالك اسباب عضوية أخرى.

الخطوة (٤) مناقشة خطة العلاج وتحديد الاهداف الرئيسية ومستوى التدخل السريري المطلوب مع المريض والاسرة

ويكون ذلك من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم طبيعيا والحفاظ على الوزن حيث ان فقدان الوزن هوعموما غير مطلوب عند الأطفال والعديد من اليافعين. لأن الحفاظ على الوزن عند الأطفال والعديد من اليافعين سيؤدي الى تناقص نسبي في الوزن خلال فترة النمو.

التداخل السريري المطلوب يتم من خلال :

- تجنب تناول الاغذية والمشروبات عالية السعرات الحرارية (سكريات، دهون، نشويات، مشروبات غازية،...)
- زيادة ممارسة النشاط البدني
- تحديد السلوك الغذائي وممارسة العادات الغذائية الصحية

الخطوة (٥) المراجعة وتقديم المساعدة الدورية المنتظمة لمعالجة زيادة الوزن والمحافظة عليه

تتم المتابعة من خلال:

١- باجراء القياسات الجسمانية شهريا لاحتساب مؤشر كتلة الجسم BMI.
٢- تثبت القراءة على منحنى النمو.
٣- متابعة التوجه (التغيير) على منحنى النمو(للعمر) شهريا.
٤- متابعة مؤشرات نجاح المعالجة :-

- تغييرسلوك الأكل
- الحد من الجوع والطلبات على الأغذية
- زيادة القدرةعلى التنظيم الذاتي
- زيادة المشاركة في النشاطات البدنية اليومية
- تحسين القدرة على ممارسة الرياضة وزيادة اللياقة
- تقليل فترة الكسل والخمول البدني
- تحسين احترام الذات والثقة.
- تحسين دعم الأسرة حول تغييرات في نمط الحياة وفي نوع المواد الغذائية وممارسة التمارين الرياضية وتقديم التوعية حول عوامل الاختطار الأيضية (الكولسترول، الدهون الثلاثية، والجلوكوز وضغط الدم).

الخطوة (٦) المشورة حول الاستراتيجية العلاجية مع المريض وعائلته:

المكونات التقليدية لتدبير الوزن للأطفال واليافعين هي نفس تلك للبالغين وهي تشمل:

١. انخفاض في أخذ الطاقة:

- الابتعاد عن المواد الغذائية عالية الطاقة
- تقليل الحصة أوتقليل حجم الوجبة
- تشجيع أنماط ألاكل الصحية على سبيل المثال إبطاء معدل سرعة الاكل وتعديل من وقت ومكان تناول الطعام.
- تناول ثلاث وجبات رئيسية وثلاث وجبات خفيفة، مع التركيز على اختيار وجبة خفيفة صحية
- تغييرتركيبة الوجبة (مع المزيد من الخضروات والفواكه والألياف).
- من الضروري عدم المساس بكميات الفيتامينات والمعادن مثل الحديد أوالكالسيوم المتناولة، لأن مرحلة الطفولة والمراهقة هي فترة النمو السريع.

٢. زيادة في صرف الطاقة: من خلال زيادة في النشاط على حد سواء المخطط لها ونمط الحياة، وهناك على الأقل ثلاثة أنواع من الأنشطة:

- أنشطة منظمة في النوادي الرياضية، دروس السباحة ونوادي الشباب.
- الأنشطة الأقل تنظيما كالرياضة في الهواء الطلق خارج المنزل وركوب الدراجة الهوائية.
- الأنشطة ضمن نمط الحياة اليومية مثلا المشي جزء من الطريق أو كله إلى المدرسة، واستخدام السلالم، والقيام بمختلف الأعمال في المنزل.
- قد يكون من الضروري النظرفي استراتيجيات أخرى لمعالجة الدرجة الشديدة من السمنة وما يرتبط بها من أمراض، لاسيما لدى اليافعين، بالاضافة الى التدخلات المذكورة أعلاه.



٣. العلاج الدوائي: تقرر من قبل الطبيب المختص

٤. الجراحة: ان الأدلة التي تفيد أن عملية جراحية في المعدة او تقليص المعدة يؤدي الى فقدان الوزن وانخفاض في معدلات الاعتلال المرتبطة بالسمنة لدى اليافعين تعتبر محدودة مقارنة بالنتائج الموجودة لدى البالغين. ولذلك ينبغي النظر بالجراحة كخيارأخيرلعلاج البدانة عند اليافعين البدناء بشدة والذين يعانون من المراضة المرتبطة بالسمنة.

الجزء الثالث

زيادة الوزن / السمنة عند المسنين

معدل انتشار السمنة يرتفع تدريجيا حتى بين كبار السن. بالرغم من ان مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر والنسب المئوية من كتلة الدهون ليست محددة لفئة كبار السن فقد بينت الدراسات أن الوفيات والمراضة المصاحبة للسمنة تزداد عندما يكون مؤشر كتلة الجسم فوق ٣٠ كغم/ م^{٢}، لذلك فان علاج السمنة لكبار السن فقط للذين يعانون من السمنة وليس زيادة الوزن وللأمراض المرتبطة بالسمنة او مضاعفاتها.



علاج السمنة لدى كبار السن:-

أن علاج السمنة يجب ان يهدف إلى التقليل من فقدان العضلات والعظام حيث ان علاج السمنة لدى كبار السن من الممكن ان يؤدي الى (سمنة ضمور العضلات) وهومزيج من تراكم الدهون في الجسم مع فقدان ضار في كتلة العضلات والكتل الخالية من الدهون بمافي ذلك العظام.

للحد من هذه النتيجة يجب أن يتكون علاج السمنة من عدة مراحل تتضمن:-

اولاً: تعزيز انماط الحياة الصحية:

<u>اتباع النظام الغذائى الصحى:</u>

- تقديم المشورة حول الوزن الصحي اعتماداً على العمر والجنس وتوزيع الدهون في الجسم.
- قياس الوزن بانتظام
- التحدث عن العادات الغذائية، بمافي ذلك استخدام المكملات الغذائية.
- توفير المعلومات الأساسية حول النظام الغذائي الصحي لكبار السن.
- اتباع نظام غذائي مع تقليل ٥٠٠ سعرة حرارية ويجب تناول كمية كافية من البروتين الطبيعي بالاضافة الى الاطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د مع العلاج السلوكي

<u>ممارسة النشاط البدنى:</u>

يتضمن تمارين متعددة مثلا التدريب على المرونة والتوازن والتمارين الرياضية الهوائية والتدريب على تمارين المقاومة. يتم تحديدها حسب ما ياتي:

- تقييم النشاط البدني المعتاد من قبل كبير السن من خلال:-

- سؤال الكبير حول النشاط البدني المعتاد خلال اليوم (في المنزل، في العمل والتنقل وفي الانشطة الترفيهية).
- تحديد فيما إذا كان النشاط البدني لكبير السن متماشياً مع ضوابط منظمة الصحة العالمية وهو ٣٠ دقيقة او اكثر باليوم لمعظم ايام الاسبوع.

- مساعدة كبير السن الذي ليس لديه نشاط بدني كافي للتخطيط لبرنامج للنشاط البدني على ان تؤخذ بنظر الاعتبار النقاط التالية:-

١- **تقييم الحالة الصحية:-**

- يعتبر المصابون بأمراض القلب والاوعية الدموعية من الفئات الخطرة حيث لا بد من اجراء التقييم الطبي قبل الشروع في اي برنامج.
- النصائح الإضافية لتعزيز النشاط البدني الآمن طبيا وللتقليل من خطر إصابات العضلات والعظام يتضمن:
  - زيادة مدة و شدة وتكرار التمرين تدريجيا وليس فجأة.
  - اداء التمارين ثلاثة ايام غير متتابعة خلال الاسبوع.
  - اجراء تمارين التمدد في الاحماء والتهدئة.

٢- **الاستمتاع في ممارسة النشاط البدني :-**

- كبار السن الذين يفقدون المتعة في ممارسة الأنشطة البدنية التي كانوا يستمتعون بها يجب مساعدتهم في:-
  - اختيار النشاط البدني الذي يستمتعون بممارسته مثل المشي.
  - تغيير النشاط البدني بين فترة واخرى..
  - مشاركة النشاط البدني مع الأصدقاءأو العائلة.
- شجع كبار السن على تحديد العوائق التي تحول دون الاستمتاع وإيجاد الحلول للتغلب عليها كما يأتي:

العوائق	الحلول المقترحة
التمارين الرياضية شاقة	ابدأ بالمشي العادي أو تمارين خفيفة تستطيع القيام بها وانتظر النتيجة.
ليس لدي الوقت	قد يكون هذا صحيحًا، لكنك لن تعرف على وجه اليقين ما لم تحاول تخصيص وقت لممارسة الرياضة.
ممارسه الرياضه متعب بالنسبة الي.	أخبر نفسك ، "هذا النشاط سيعطيني المزيد من الطاقة." تحقق مما إذا لم يحدث ذلك.
أنا قلق من الفشل في الاستمرار في ممارسة الرياضة لذا لن أفعل.	النشاط البدني ليس اختبارًا. لن تفشل إذا كنت اخترت النشاط الذي تريده وابدأ ببطء تحديد أهداف واقعية معقولة تقلل من فرص بالفشل.
ليس لدي أي شخص يمارس الرياضة معي.	ربما لم تسأل صديقاً أو جار أو زميلاً عمل لمشاركتك. أو يمكنك اختيار نشاط تستمتع به بنفسك
ليس هناك مكان مناسب	اختر نشاطًا يمكنك القيام به في مكان مناسب مثلا المشي في منطقتك أو مركز تجاري قريب، أو القيام بتمارين مع برنامج تلفزيوني أو شريط فيديو في المنزل.
أنا خائف من حدوث أصابات	المشي في منطقة مضاءة جيداً تعتبر ممارسة ممتازة وآمنة.
الطقس سيء للغاية	حاول ممارسة انشطة رياضية تقوم بها بنفسك في مكان ووقت مناسب.

٣- **النشاط البدني المناسب:-** تشجيع كبير السن على المشاركة في الأنشطة البدنية التي تحتاج الى أبسط التحضيرات والتي يمكن ان يستمتع بها والتي تتناسب مع حالته الصحية وأنشطته اليومية.

٤- **النشاط البدني الواقعي:-** يجب ممارسة النشاط البدني تدريجياً من حيث الشدة ومدة النشاط حتى يصبح النشاط البدني جزء من الاعمال اليومية لكبير السن.

٥- **النشاط البدني المنظم:-** يجب ان يكون النشاط البدني وفق خطة وبجدول زمني محدد.

ثانياً: العلاج الدوائي للسمنة والعملية الجراحية لكبار السن غيرمعروفة النتائج.

الجزء الرابع:

الوقاية من السمنة:

قد تتسبب العديد من العوامل زيادة الوزن والسمنة ولكن مع أتباع نظام غذائي صحي وأسلوب حياة نشط بدنيا مع الالتزام طويل الامد يساعد على الحفاظ على الوزن الصحي.

للحفاظ على نظام غذائي صحي التأكد من:

- تناول وجبات صحية ووجبات خفيف، التركيز على اغذية منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالقيمة الغذائية مثل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة.
- تجنب الدهون المشبعة والحد من تناول الحلويات.
- الاعتماد في الوجبات على الأطعمة النشوية مثلا البطاطا والخبز والأرز والمعكرونة، واختيار الحبوب الكاملة حيثما أمكن.
- تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والفول والبازلاء والعدس والحبوب.
- مراقبة حجم الحصص الغذائية في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة، والفاصل الزمني بين وجبات الطعام.

للحفاظ على أسلوب حياة نشط ولتحقيق الفائدة الصحية من النشاط البدني بالنسبة للبالغين يجب أن يحققوا ٦٠٠ MET من النشاط البدني أسبوعيا وكالأتي :

- نشاط متوسط الشدة ٤ MET لمدة ٣٠ دقيقة في اليوم على الأقل ٥ أيام/ أسبوع على الأقل (١٥٠ دقيقة في الأسبوع).
- أو نشاط شاق ٨-١٠ MET لمدة ٢٠ دقيقة في اليوم على الأقل ٣ أيام/ أسبوع (٧٥ دقيقة في الأسبوع).
- أو نشاط متوسط و نشاط شاق مجموعه ٦٠٠ MET في الأسبوع.
- تجنب الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون أو لعبة فيديو.
- متابعة الوزن بانتظام مرة واحدة أسبوعيا هو أكثر نجاحاً في الحفاظ على الوزن والتخلص من الوزن الزائد، كما أنه يكشف زيادة الوزن الصغيرة قبل أن تصبح مشكلة كبيرة.
- الالتزام قدر الامكان بالنظام الغذائي والنشاط البدني خلال العطل والمناسبات يزيد احتمالية النجاح في الحفاظ على الوزن.



الملحق(١)

مؤشركتلة الجسم وعلاقته بالطول والوزن

Body Mass Index (BMI) Charts

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/bmi-chart.html

© 2009 Vertex42 LLC

Body Mass Index (BMI) Table for Adults

Obese (>30) | Overweight (25-30) | Normal (18.5-25) | Underweight (<18.5)

HEIGHT in feet/inches and centimeters

WEIGHT		4'8"	4'9"	4'10"	4'11"	5'0"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"
lbs	(kg)	142cm		147	150	152	155	157	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196
260	**(117.9)**	**58**	**56**	**54**	**53**	**51**	**49**	**48**	**46**	**45**	**43**	**42**	**41**	**40**	**38**	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**32**	**31**
255	(115.7)	57	55	53	51	50	48	47	45	44	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30
250	**(113.4)**	**56**	**54**	**52**	**50**	**49**	**47**	**46**	**44**	**43**	**42**	**40**	**39**	**38**	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**31**	**30**	**30**
245	(111.1)	55	53	51	49	48	46	45	43	42	41	40	38	37	36	35	34	33	32	31	31	30	29
240	**(108.9)**	**54**	**52**	**50**	**48**	**47**	**45**	**44**	**43**	**41**	**40**	**39**	**38**	**36**	**35**	**34**	**33**	**33**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**
235	(106.6)	53	51	49	47	46	44	43	42	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	29	28
230	**(104.3)**	**52**	**50**	**48**	**46**	**45**	**43**	**42**	**41**	**39**	**38**	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**31**	**30**	**30**	**29**	**28**	**27**
225	(102.1)	50	49	47	45	44	43	41	40	39	37	36	35	34	33	32	31	31	30	29	28	27	27
220	**(99.8)**	**49**	**48**	**46**	**44**	**43**	**42**	**40**	**39**	**38**	**37**	**36**	**34**	**33**	**32**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**	**27**	**27**	**26**
215	(97.5)	48	47	45	43	42	41	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	28	27	26	25
210	**(95.3)**	**47**	**45**	**44**	**42**	**41**	**40**	**38**	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**	**28**	**27**	**26**	**26**	**25**
205	(93.0)	46	44	43	41	40	39	37	36	35	34	33	32	31	30	29	29	28	27	26	26	25	24
200	**(90.7)**	**45**	**43**	**42**	**40**	**39**	**38**	**37**	**35**	**34**	**33**	**32**	**31**	**30**	**30**	**29**	**28**	**27**	**26**	**26**	**25**	**24**	**24**
195	(88.5)	44	42	41	39	38	37	36	35	33	32	31	31	30	29	28	27	26	26	25	24	24	23
190	**(86.2)**	**43**	**41**	**40**	**38**	**37**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**	**27**	**26**	**26**	**25**	**24**	**24**	**23**	**23**
185	(83.9)	41	40	39	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	23	22
180	**(81.6)**	**40**	**39**	**38**	**36**	**35**	**34**	**33**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**	**27**	**27**	**26**	**25**	**24**	**24**	**23**	**22**	**22**	**21**
175	(79.4)	39	38	37	35	34	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	22	22	21	21
170	**(77.1)**	**38**	**37**	**36**	**34**	**33**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**	**27**	**27**	**26**	**25**	**24**	**24**	**23**	**22**	**22**	**21**	**21**	**20**
165	(74.8)	37	36	34	33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	22	22	21	21	20	20
160	**(72.6)**	**36**	**35**	**33**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**	**27**	**27**	**26**	**25**	**24**	**24**	**23**	**22**	**22**	**21**	**21**	**20**	**19**	**19**
155	(70.3)	35	34	32	31	30	29	28	27	27	26	25	24	24	23	22	22	21	20	20	19	19	18
150	**(68.0)**	**34**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**	**27**	**27**	**26**	**25**	**24**	**23**	**23**	**22**	**22**	**21**	**20**	**20**	**19**	**19**	**18**	**18**
145	(65.8)	33	31	30	29	28	27	27	26	25	24	23	23	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
140	**(63.5)**	**31**	**30**	**29**	**28**	**27**	**26**	**26**	**25**	**24**	**23**	**23**	**22**	**21**	**21**	**20**	**20**	**19**	**18**	**18**	**17**	**17**	**17**
135	(61.2)	30	29	28	27	26	26	25	24	23	22	22	21	21	20	19	19	18	18	17	17	16	16
130	**(59.0)**	**29**	**28**	**27**	**26**	**25**	**25**	**24**	**23**	**22**	**22**	**21**	**20**	**20**	**19**	**19**	**18**	**18**	**17**	**17**	**16**	**16**	**15**
125	(56.7)	28	27	26	25	24	24	23	22	21	21	20	20	19	18	18	17	17	16	16	16	15	15
120	**(54.4)**	**27**	**26**	**25**	**24**	**23**	**23**	**22**	**21**	**21**	**20**	**19**	**19**	**18**	**18**	**17**	**17**	**16**	**16**	**15**	**15**	**15**	**14**
115	(52.2)	26	25	24	23	22	22	21	20	20	19	19	18	17	17	16	16	16	15	15	14	14	14
110	**(49.9)**	**25**	**24**	**23**	**22**	**21**	**21**	**20**	**19**	**19**	**18**	**18**	**17**	**17**	**16**	**16**	**15**	**15**	**15**	**14**	**14**	**13**	**13**
105	(47.6)	24	23	22	21	21	20	19	19	18	17	17	16	16	16	15	15	14	14	13	13	13	12
100	**(45.4)**	**22**	**22**	**21**	**20**	**20**	**19**	**18**	**18**	**17**	**17**	**16**	**16**	**15**	**15**	**14**	**14**	**14**	**13**	**13**	**12**	**12**	**12**
95	(43.1)	21	21	20	19	19	18	17	17	16	16	15	15	14	14	14	13	13	13	12	12	12	11
90	**(40.8)**	**20**	**19**	**19**	**18**	**18**	**17**	**16**	**16**	**15**	**15**	**15**	**14**	**14**	**13**	**13**	**13**	**12**	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**
85	(38.6)	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	13	12	12	12	11	11	11	10	10
80	**(36.3)**	**18**	**17**	**17**	**16**	**16**	**15**	**15**	**14**	**14**	**13**	**13**	**13**	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**	**11**	**10**	**10**	**10**	**9**

Note: BMI values rounded to the nearest whole number. BMI categories based on CDC (Centers for Disease Control and Prevention) criteria.

https://www.vertex42.com BMI = Weight[kg] / (Height[m] x Height[m]) = 703 x Weight[lb] / (Height[in] x Height[in]) © 2009 Vertex42 LLC

الملحق (٢)

أ. النظام الغذائي ذو السعرات الحرارية المنخفضة للنساء (قائمة المأكولات تحتوي على حوالي ١٢٠٠ سعره حرارية) تتكون القائمة من الوجبات التالية:

الغذاء	الوزن/غم	الكمية	السعرات الحرارية
الافطار			
الخبز الفرنسي أو الخبز الأسمر	٥٠-٦٠	½ رغيف	١٣٣
الحليب منزوع الدسم	٢٥٠	١كوب	٩٠
البيض المسلوق أو الجبن قليل الدسم	٥٠-٦٠	بيضة متوسط أو ٣ شرائح	٨١- ١٠٢
١٠:٠٠ صباحاً			
فاكهة	-	١ -متنوعة	٦٠
الغداء			
الخبز الفرنسي أو الخبز الأسمر	٥٠-٦٠	½ رغيف	١٣٣
الخضار المطبوخة(مرق) مع ملعقة صغير ة من زيت	-	½كوب	٦٥
سلطة مختلف+ ملعقة صغيرة من ز يت الزيتون بدون ملح	-	½كوب	٧٠
العشاء			
صدر الدجاج المشوي أو السمك أو لحوم البقر أو الضأن المشوي قليل الدسم	٩٠	قطعة بحجم بيضة متوسطة	١٥٠- ٢٥٥
سلطة مختلفة	-	½كوب	٢٥
الخبز الفرنسي أو الخبز البني	٢٥- ٣٠	¼الرغيف	٦٦
البقوليات المطبوخة مع ملعقة صغيرة من زيت	-	¼كوب	١٦٠
قبل النوم			
الفاكهة	-	-	٦٠

ملاحظات:

١	ملعقة صغيرة٥ = سم	٦	(٣٠)غم من اللحم يعوض بنصف كوب من المكسرات خالية الملح او بيضة واحدة
٢	١كوب ٢٥٠ = سم مكعب	٧	يجب أن تؤكل الأسماك على الأقل مرتين في الأسبوع
٣	يجب شرب الشاي بدون سكر ويمكن استخدام المحليات	٨	كل (٩٠) غرام من اللحم يساوي على الأقل حجم بيضة متوسطة الحجم
٤	شرب ٨ أكواب من الماء كل يوم وأكثر من ذلك في درجات الحرارة الأعلى.	٩	مختلف أنواع السلطة (الخيار والطماطم والجزر، واللهانة، الخس، الفجل، البصل، الخضار الورقية مثل الكرفس، الرشاد، والبقدونس)
٥	ربع من الرغيف يعادل شريحة واحدة من التوست او نصف كوب من الرز	١٠	وينبغي دائما أن تؤكل سلطة بدون ملح

ب .النظام الغذائي ذو السعرات الحرارية المنخفضة للرجال (قائمة المأكولات تحتوي على حوالي ١٨٠٠ سعره حرارية) تتكون القائمة من الوجبات التالية:

الغذاء	الوزن/ غم	الكمية	السعرات الحرارية
الإفطار			
الخبزالفرنسي أو رغيف خبز أسمر	٥٠-٦٠	١/٢الخبز	١٣٣
الحليب منزوع الدسم	٢٥٠	١ كوب	٩٠
البيض المسلوق أوقليل الدسم والجبن	٥٠-٦٠	متوسط بيضة أو ٣ شرائح	٨٨- ١٠٢
١٠:٠٠صباحا			
فاكهة	-	مبادلة	١٢٠
الغذاء			
الخبز الفرنسي أورغيف خبز أسمر	٥٠-٦٠	١/٢الخبز	١٣٣
الخضار المطبوخة(مرق) مع ملعقة صغيرة من زيت	-	١كوب	**٧٥**
سلطة مختلفة+ملعقة صغيرة من زيت الزيتون بدون ملح	-	١ كوب	٧٠
زبادي منزوع الدسم أو حليب	-	١كوب	**٩٠**
الساعة الخامسة مساء			
فاكهة	-	مبادلة	**٦٠**
العشاء			
صدر الدجاج أوالسمك أو لحوم البقر أو الضأن قليل الدسم المشوي	١٥٠	متوسط الحجم	١٧٥ -٣٧٥
سلطة مختلفة + ملعقة صغيرة من زيت الزيتون	-	١/٢ كوب	٧٠
الخبز الفرنسي أو رغيف خبز أسمر	٥٠-٦٠	١/٢ رغيف الخبز	١٣٣
البقوليات المطبوخة مع ملعقة صغيرة من زيت	-	١/٤ كوب	١٦٠
زبادي منزوع الدسم	١كوب	٢٥٠	٩٠
قبل النوم			
الفاكهة	-	مبادلة واحدة	١٢٠

ملاحظات:

١.	ملعقة صغيرة ٥ = سس	٦.	٣٠ غم من اللحوم تعوض بنصف كوب من المكسرات الخالية من الاملاح
٢.	١ كوب ٢٥٠ = سم مكعب	٧.	الأسماك يجب أن تؤكل على الأقل مرتين في الأسبوع
٣.	شرب الشاي يجب ان يكون بدون سكر .ويمكن استخدام المحليات	٨.	كل (٩٠) غرام من اللحم يساوي على الأقل حجم بيضة متوسطة الحجم
٤.	شرب ٨ أكواب من الماء كل يوم، وأكثر من ذلك في الدرجات الحرارة الأعلى	٩.	مختلف أنواع السلطة (الخيار والطماطم والجزر،والملفوف،الخس،الفجل،البصل،الخضار الورقية مثل الكرفس، الرشاد، والبقدونس)
٥.	ربع من الرغيف يعادل شريحة واحدة من التوست او نصف كوب من الرز	١٠.	وينبغي دائما أن تؤكل سلطة بدون ملح.

المبادلات الغذائية الأجزاء وما يقابلها (وفقا للمجموعات الغذائية)

١ -الحبوب:

وتشمل القمح والشعير والأرز ومنتجاتها مثل الكعكة، والخبز الفرنسي وجميع أنواع المعكرونة.
كل ١ جزء يساوي ¼الخبز،الذي هو(٣٠) غم أو ½ كوب من الأرز أو البرغل أوالمعكرونة المطبوخة الخالية من الزيت.

٢- **الخضروات:** كل انواع الخضراوات



٣- الفواكه: تشمل كل أنواع الفواكه المتاحة؛ الطازجة والمجففة أوعصائر من الفواكه.

كل جزء يساوي: قطعة متوسطة الحجم مثل التفاح أو الموز(الموز الصغيرة) او نصف كوب عصير فاكهة

٤- الدهون والزيوت

- وتشمل الدهون الحيوانية المشبعة الموجودة في اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى،وكذلك منتجات الألبان والزيوت النباتية السائلة (غيرالمشبعة) مثل زيت الزيتون والذرة وعباد الشمس.

- كل جزء يساوي ملعقة صغيرة ٥مل

كل جزء يعادل:

- الدهون المشبعة ملعقة صغيرة ٥مل (من الزبدة أو ٢ ملعقة طعام (١٥ مل) قشطة أوملعقة كبيرة من المايونيز.

- الزيوت غيرالمشبعة ملعقة كوب ٥ مل من زيوت نباتية (زيت الزيتون و زيت الذرة أو زيت عباد الشمس، الكانولا والفول السوداني).

وممكن ان تشمل ١٥ غرام بذور مثل زهرة الشمس ، القرع او اليقطين (مايعادل ملعقة طعام)، خليط مكسرات ٦ حبات ، الطحينية (الراشي) ٢ ملعقة كوب، زيتون ٨ حبات

٥- منتجات الألبان:

- تشمل الحليب (منزوع الدسم أوقليل الدسم) ومنتجاته مثل اللبن والجبن التي هي غنية بالكالسيوم.
- كل جزء يساوي كوب ٢٥٠ مل من الحليب.
- اوكوب من اللبن الزبادي أو ٤٥ غم من الجبنة البيضاء أو ٦٠ غرام من الجبن المطبوخ.

٦- اللحوم والبقوليات:

- تشمل (لحوم البقر والضأن ولحوم الدجاج منزوعة الجلد وكذلك السمك، البيض والبقوليات).
- كل جزء يعادل ٣٠ غم من اللحوم (بدون شحم)، بيضة متوسطة الحجم (٥٠ غم (١/٤) كو ب من البقوليات المطبوخة)

الملحق (٣)

الارشادات والتوصيات الوطنية بشأن النشاط البدني:

من عمر ٥-١٢ سنة

يجب ان لايقضي طفلك اكثر من ساعتين في اليوم خاملا ويجب تشجيعه على القيام بالانشطة الرياضية لاسيما بالاوقات التي يمكن ان يستمتع فيها بمزيد من الأنشطة.

اذا كان طفلك قد بدأ لتوه في النشاط فأبدأ بنشاط متوسط الشدة اقل من ٣٠ دقيقة يومياً ويزداد تدريجياً.

يحتاج الاطفال الى الفرصة للمشاركة في مجموعة متنوعة من الانشطة الترفيهية التي تتناسب مع اهتماماتهم ومهاراتهم وقدراتهم وسوف تقدم مجموعة متنوعة لطفلك من الفوائد الصحية والخبرات والتحديات.

من عمر ١٢-١٨

اختر مجموعة من الانشطة التي تحبها او ترغب في تجربتها ، كن نشيطا مع اصدقائك ، من المرجح ان تظل نشيطاً اذا كان ذلك ممتعا وان يكون لديك اشخاص تستمتع بمرافقتهم ، اكثر من المشي الى المدرسة او زيارة الاصدقاء او المتاجر او اماكن اخرى في منطقتك ، حاول تضيق الوقت الذي تقضيه في مشاهدة التلفزيون

من عمر ١٨-٦٠

فكر في الحركة كفرصة وليست ازعاجا حيث ينظر الى أي شكل من الشكال حركة الجسم على انه فرصة لتحسين الصحة وليس كتضييع للوقت،

كن نشيطاً كل يوم بأكبر عدد ممكن من الطرق ، يمكنك عادةً المشي او ركوب الدراجات بدلا من استخدام السيارة، او القيام بالاشياء بنفسك بدلاً من استخدام آللات لتوفر العمالة ، اجمع ما لايقل عن ٣٠ دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة في اليوم وعلى شكل جلسات على ان لاتقل الجلسة الواحدة عن ١٠ دقائق

من عمر ٦٥ فما فوق

فكر في الحركة كفرصة وليست ازعاجاً

كن نشيطاً كل يوم باكبر عدد ممكن من الطرق

اجمع ما لايقل عن ٣٠ دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة في اليوم وعلى شكل جلسات على ان لاتقل الجلسة الواحدة عن ١٠ دقائق

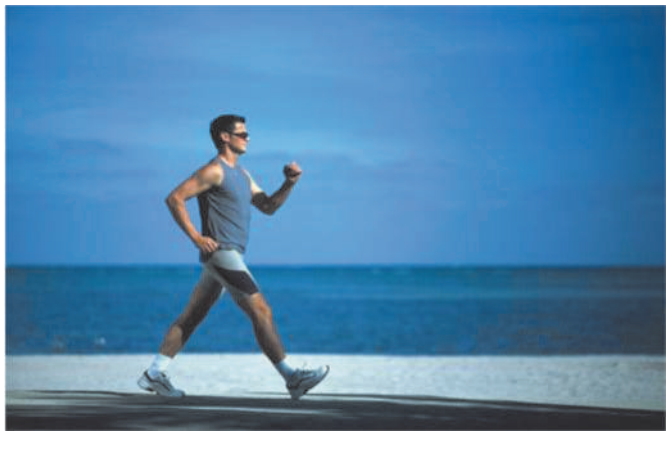
استخدم معدات السلامة والحماية المناسبة لزيادة السلامة وتقليل خطر الاصابة اثناء النشاط البدني على سبيل المثال استخدام الاحذية الداعمة للمشي وخوذة لركوب الدرجات

التمارين

بالإضافة إلى الانشطة الهوائية، فإن حمل الاثقال أو تمارين المقاومة تقوي ليس فقط العضلات والعظام، ولكن أيضا ترفع من الايض عن طريق زيادة نسبة العضلات الى الدهون وحرق مزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة. وأخيرا ينبغي أن يتضمن البرنامج ممارسة تمارين التمدد لتعزيز المرونة والتنقل.
عند بدء البرنامج يجب التركيز على نوعية وكمية التمرين وليس على كمية الوزن المفقودة، وينبغي أن يكون التركيز على ممارسة التمارين (الهوائية aerobic) والتي تكون مهمة للقلب والأوعية الدموية لأنها توفر الفوائد الصحية الشاملة، بما في ذلك فقدان الدهون، وزيادة في مستويات الطاقة اليومية والحد من المخاطر الصحية.
عدد مرات ممارسة التمارين : التمرين ٥-٤ مرات في الأسبوع

الفترة الزمنية لكل جلسة: من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة لكل جلسة من النشاط البدني الخفيف الى معتدل الشدة

- ابدأ ببطء، ينبغي أن تكون الدقائق الخمس الاولى" الاحماء "لإعطاء الجسم الوقت اللازم فإنه يحتاج إلى التعودعلى النشاط.
- الاستمراربدرجة شدة مريحة التي تسمح– بالتحدث من دون صعوبة وليس التعرق بغزارة
- الإبطاء في آخرخمس دقائق من التمارين للسماح لعودة الدم من العضلات العاملة إلى القلب وللجسم للعودة إلى حالة الاستراحة أوالسكون.
- الانتهاء بتمارين التمدد.
- التركيز على زيادة المدة اولا ومن ثم زيادة الكثافة.
- برنامج تدريب المقاومة يوصى لمن هم يعانو ن من السمنة المفرطة.
- أداء التمارين التي تستهدف مجموعات العضلات الرئيسية، مثل الصدروالظهروالكتفين، بالإضافة إلى آلات الوزن والدمبلص Dumbbells ، يمكن استخدام أنابيب مطاطية أوأربطة مرنة لتوفيرالمقاومة.
- تدفئة الجسم ببطء قبل تدريب المقاومة،على سبيل المثال، المشي لمدة ١٠ دقيقة على الأقل.
- دائما تنفيذ التمارين بطريقة بطيئة ومسيطر عليها يضمن أداءعمل العضلات المستهدفة.



ملحق (٤) امثلة على ممارسة النشاط البدني (وحدة احتساب الايض المكافىء)

مثال (١)

طالب في المرحلة المتوسطة يستخدم الدراجة الهوائية للذهاب الى المدرسة فكانت المدة التي يستغرقها على الدراجة الهوائية ذهابا وايابا (٣٠ دقيقة) لمدة خمسة أيام بالاسبوع. ماهي الطاقة التي يصرفها الطالب اسبوعيا؟ وهل الطالب نشط أم غير نشط؟

ج/ ٣٠ * ٥*٤= ٦٠٠ met

اذن هذا الطالب نشط اذ تتحقق الفائدة الصحية من خلال نشاطه المتمثل بركوب الدراجة الهوائية.

مثال (٢)

شخص يقوم برياضة المشي السريع في اوقات الفراغ لمدة يومان في الاسبوع بواقع (٢٠ دقيقة) في اليوم. ماهي الطاقة التي يصرفها الشخص وهل يتم اعتباره نشط او غير نشط

ج/ ٢٠ * ٢*٨= ٣٢٠ met

اذن الشخص غير نشط اذ لا تتحقق الفائدة الصحية من خلال نشاطه المتمثل بالجري السريع.

مثال (٣)

طالب يذهب الى مدرسته صباحا مشيا سريعا على الاقدام يوميا ويستغرق (١٠دقائق) ذهابا و (١٠دقائق) ايابا اضافة الى ممارسة التمارين الرياضية في درس الرياضة (كرة السلة) لمدة ١٥دقيقة للشوط الاول و١٥ دقيقة للشوط الثاني لمدة حصتين في الاسبوع، ماهي الطاقة المصروفة من قبل الطالب اسبوعيا وهل هو نشط ام غير نشط؟

ج/ ٢٠*٥*٤= ٤٠٠ met

٣٠* ٢ *٨ =٤٨٠ met

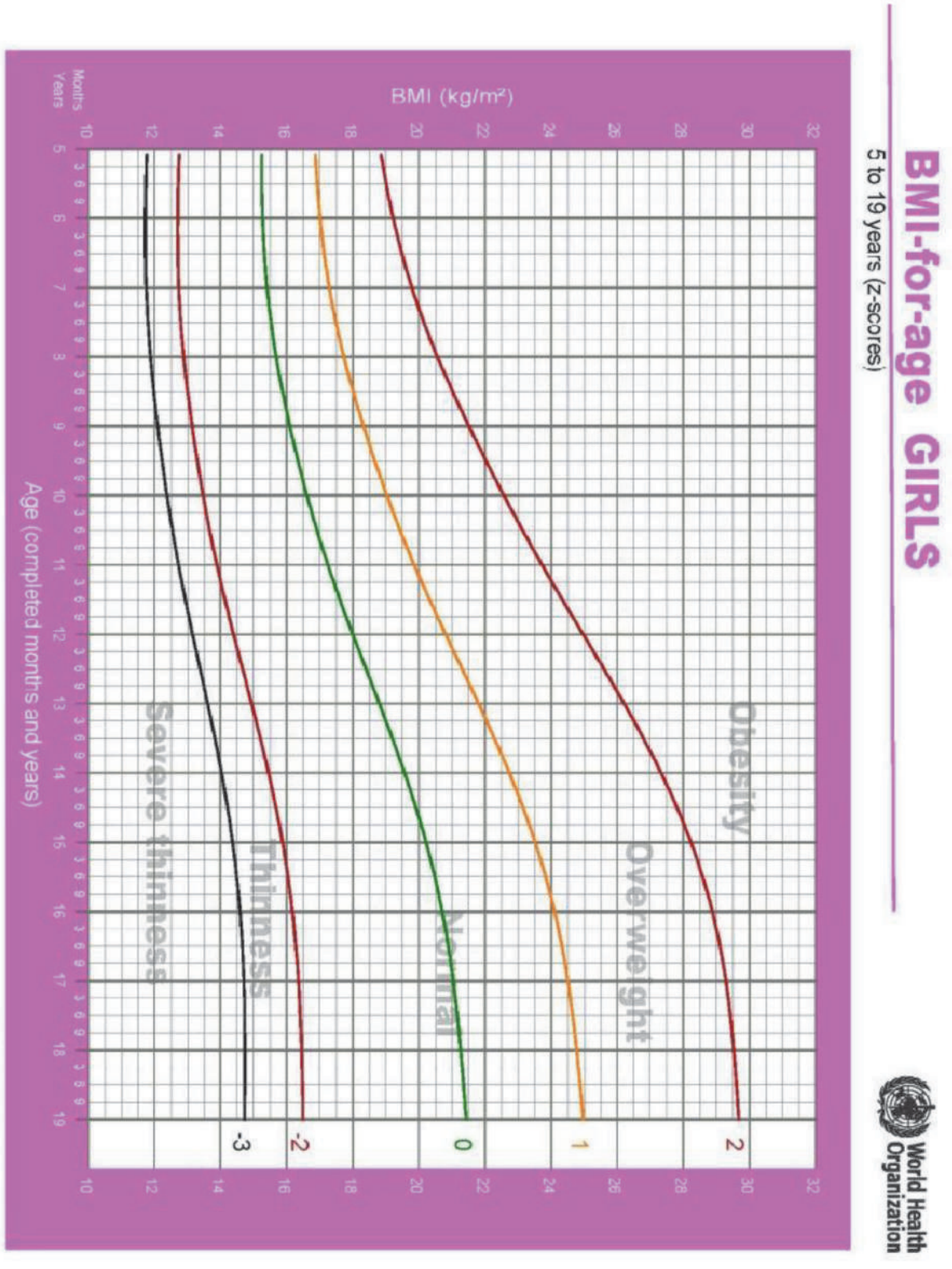
٤٠٠+٤٨٠=٨٨٠ met

اذن هذا الطالب نشط اذ تتحقق الفائدة الصحية من خلال نشاطه المتمثل بالمشي الصحي ورياضة كرة السلة.

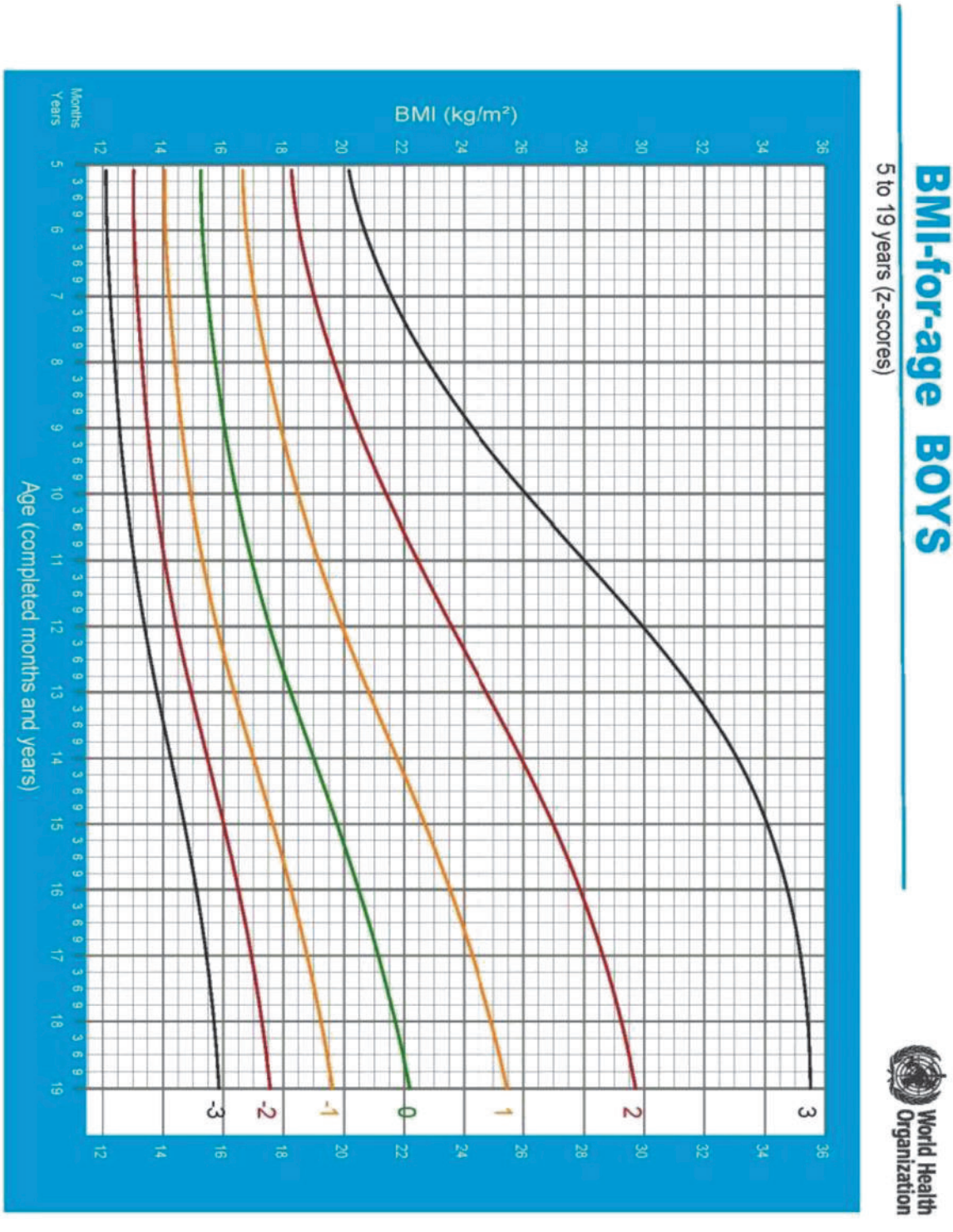


الملحق (٥)

BMI للفتيات العمر (٥-١٩ سنة)



BMI للأولاد العمر(٥-١٩ سنة)



استمارة تقييم

المهمة	حقق المهمة؟		تعليقات
	نعم	كلا	
١-تقييم السمنة			
الطول			
الوزن			
مؤشركتلة الجسم			
محيط الخصر			
٢ .تقييم الأمراض المرافقة (المشارإليها) وعامل الخطورة			
ضغط الدم			
تحليل البلازما في حالة الصيام • الجلوكوز • نسبة الكولسترول في الدم • الإنسولين			
اختبارات وظائف الكبد			
اختبارات الغدد الصماء			
امراض الصحة الإنجابية			
٣.تقييم عوامل الخطر			
هل هناك تاريخ لزيادة الوزن في الأسرة؟			
هل هناك تاريخ من زيادة الوزن في الفرد؟			
الأسرة والعمل والبيئة الاجتماعية			
٤.تقييم لماذا وكيف حدث اختلال التوازن في الطاقة			
تنظيم وجبات الغذاء			
جائع دائما			
أكثرمن ثلاث وجبات خفيفة بين الوجبات			
تناول الطعام أمام التلفزيون			
هل المواد الغذائية استخدمت للتسلية أوكهدية؟			
تدخين			
القضايا النفسية			
إجهاد نفسي			
٥.تحديد مستوى التدخل المطلوب مع إستراتيجية العلاج والأهداف تقسم الى/			
خفض كمية الطاقة الغذائية			
تغييرنمط الحياة والتخطيط لزيادة النشاط			
خفض السلوكيات المتعلقة بقلة الحركة			
الرجوع إلى متخصص			
٦.متابعة للحفاظ على فقدان الوزن			
التغييرات في النظام الغذائي مستدامة			
زيادة النشاط البدني المخطط له وغير المخطط له			
رصد الوزن بانتظام			

References

المراجع

1- Iraqi National Annual Survey 2006-MoH/Nutritional Institute
2- Overweight And Obesity In Adults a Guide for General Practitioners
3- Canadian clinical practice guidelines on the management and prevention of obesity in adults and children 2006, Canadian Medical Association Journal. Available at http://www.cmaj.ca/content/suppl/2007/09/04/176.8.S1.DC1/obesity-lau-onlineNEW.pdf
4- Mathus-Vliegen EM. Prevalence, pathophysiology, health consequences and treatment options of obesity in the elderly: a guideline. Obes Facts. 2012;5(3):460-83. [PMID: 22797374]
5- Lee CY, Koren G. Maternal obesity: effect on pregnancy and the role of pre-conception counseling. J ObstetGynecol2010 ;30:101-106.
6- (Kristensen J, Vestergaard M, Wisborg K, Kesmodel U, Secher NJ. Pre-pregnancy weight and the risk of stillbirth and neonatal death. BJOG 2005; 112:403-408.6-
7- Center for Maternal and Child Enquiries. Management of women with obesity in pregnancy.London: CEMACH,2010. Available at www.cemach.og.uk/getattachment/26cfa33c-723b-45c5-abee-4d00b0d7be4c/Joint-CMACE-RCOG-Guideline-Management-of-Obesity.aspx
8- Balen AH, Conway GS, Kaltsas G et al. Polycystic ovarian syndrome: The spectrum of the disorder in 1741 patients. Hum Reprod 1990; 10:2107-2111.
9- Preventing overweight and obesity in Scotland a route map towards healthy weight available at http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/302783/0094795.pdf
10- National Institute for Health and Clinical Excellence, guidance on the prevention, identification, assessment and management of overweight and obesity in adults and children. Available at http://www.playfieldinstitute.co.uk/information/pdfs/publications/eating_disorders/obesity_nice_guidence.pdf 101-
11- International Diabetes Federation, the IDF consensus world wide definition of the metabolic syndrome (2006) Available at http://www.idf.org/webdata/docs/MetSyndrome_FINAL.pdf11-
12- American Diabetes Association Standards in medical care in diabetes 201212-
13- Clinical Practice Guidelines for the Management of Overweight and Obesity in Adults,Adolescents and Children in Australia (2010)
14- Dennedy and Dunne, 2010; leddy et al, 2008
15- Whitaker, 2004; reily et al, 2005; catalano and Ehrenberg, 2006; Oken, 2009 Clinical diabetes journal, Vol 17, no. 3, 1999 available at http://journal.diabetes.org/clinicaldiabetes/V17n31999/Pg142.htm
16- World Health Organization. (2010). Global recommendations on physical activity for health. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44399
17- Al-Hazzaa, Hazaa Muhammad: Physical activity guide for health workers in the Gulf Cooperation Council countries. Riyadh: Council of Health Ministers of the Gulf Cooperation Council, 2014
18- Khazzal,F. Khaleefah, M,A., Management of Overweight/Obesity for primary health care workers, 2014

المحتويات

الموضوع	الصحفة
المقدمة	١
الهدف من هذا الدليل	١
التعريف	١
الجزء الاول : معالجة زيادة الوزن والسمنة لدى البالغين	٢
ست خطوات لمعالجة زيادة الوزن والسمنة	٢
الخطوة (١) قياس مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر	٢
الخطوة (٢) تقييم الاسباب الكامنة وعوامل الخطورة لزيادة الوزن والسمنة	٣
الخطوة (٣) تقييم المراضة المصاحبة	٣
الخطوة (٤) تحديد الاهداف ومستويات المعالجة	٣
الخطوة (٥) تقديم المشورة للعلاج الغذائي وتعزيز النشاط البدني	٤
الخطوة (٦) الادوية أو اللجوء لجراحة السمنة	٩
الجزء الثاني : زيادة الوزن والسمنة لدى الاطفال واليافعين	١٠
يتم اتباع خمس خطوات لمعالجة زيادة الوزن والسمنة لدى الاطفال واليافعين	١٠
الخطوة (١) تقييم مدى زيادة الوزن والسمنة في الاطفال او اليافعين	١٠
الخطوة (٢) تقييم الامراض المصاحبة لزيادة الوزن/ السمنة، والتعامل مع كل حالة بصورة منفردة	١١
الخطوة (٣) تحديد المسببات وعوامل الخطورة لزيادة الوزن/ البدانة	١١
الخطوة (٤) مناقشة خطة العلاج وتحديد الاهداف الرئيسية ومستوى التدخل السريري المطلوب مع المريض والا	١٢
الخطوة (٥) مراجعة وتقديم المساعدة الدورية المنتظمة لمعالجة زيادة الوزن والحفاظ عليه	١٣
الخطوة (٦) المشورة حول الاستراتيجية العلاجية مع المريض وعائلته	١٣
الجزء الثالث : زيادة الوزن والسمنة لدى المسنين	١٥
الجزء الرابع : الوقاية من السمنة	١٧
ملحق (١) مؤشر كتلة الجسم وعلاقتة بالطول والوزن	١٨
ملحق (٢) أ حمية السعرات الحرارية القليلة للنساء يحتوي على قائمة المأكولات نحو ١٢٠٠سعرة حرارية	١٩
ملحق (٢) ب النظام الغذائي ذات السعرات الحرارية المنخفضة للرجال (قائمةالمأكولات تحتوي على حوالي ٨٠٠ سعره حرارية حرارية)	٢٠
المبادلات الغذائية الاجزاء وما يقابلها (وفقا للمجموعات الغذائية)	٢١
ملحق (٣) الارشادات والتوصيات الوطنية بشأن النشاط البدني	٢٢
التمارين	٢٣
ملحق (٤) أمثلة على ممارسة النشاط البدني (وحدة احتساب الايض المكافئء)	٢٤
ملحق (٥) مؤشر كتلة الجسم للاعمار ٥-١٩ سنة	٢٥,٢٦
استمارة التقييم	٢٧
المراجع	٢٨

مطابع دائرة العيادات الطبية الشعبية
للطباعة والتصميم
بغداد